Evaluación del riesgo suicida

Preguntas de cribado, factores de riesgo y protección, y plan de seguridad.

Consideraciones previas

Pregunte de forma directa, empática y sin eufemismos. Preguntar por el suicidio no aumenta el riesgo y puede aliviar al paciente. La evaluación es un proceso clínico continuo: ningún cuestionario predice por sí solo la conducta suicida.

Preguntas de cribado

Preguntas orientativas, ordenadas de menor a mayor especificidad. No sustituyen a instrumentos validados en su versión oficial (p. ej. la C-SSRS), que requieren formación específica.

Pregunta (último mes, salvo indicación)	Sí	No	Observaciones
¿Ha deseado estar muerto/a o dormirse y no despertar?			
¿Ha pensado en quitarse la vida?			
¿Ha pensado en cómo lo haría?			
¿Ha tenido intención de llevarlo a cabo?			
¿Ha planificado los detalles o tiene acceso a medios?			
¿Ha hecho algo para prepararlo o ha empezado a hacerlo (ensayos, despedidas, cartas)?			
¿Ha intentado quitarse la vida alguna vez? ¿Cuándo?			
¿Se ha autolesionado sin intención suicida?			

Factores de riesgo y de protección

Área	Factores de riesgo	Factores de protección
Clínicos	Intentos previos, depresión grave, desesperanza, impulsividad, consumo de sustancias, insomnio, dolor crónico.	Vinculación al tratamiento, buena adherencia, ausencia de síntomas psicóticos activos.
Psicosociales	Pérdidas o conflictos recientes, aislamiento, violencia, problemas económicos o legales, desempleo.	Red de apoyo, responsabilidades familiares o con mascotas, sentido de pertenencia.
Cognitivos	Visión de túnel, sentirse una carga, falta de razones para vivir.	Capacidad de resolución de problemas, razones para vivir, creencias que desaconsejan el suicidio.
Acceso a medios	Medicación acumulada, armas, acceso a lugares elevados.	Restricción de medios acordada.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.

Valoración y actuación

Nivel orientativo	Indicadores	Actuación
Bajo	Ideación pasiva, sin plan ni intención; factores protectores presentes.	Plan de seguridad, seguimiento en sesiones, facilitar el 024.
Moderado	Ideación activa sin intención clara, o plan sin preparativos.	Plan de seguridad detallado, aumentar frecuencia de contacto, implicar a la red de apoyo con consentimiento, coordinación con médico/a o psiquiatría.
Alto	Intención, plan con acceso a medios, preparativos o intento reciente.	No dejar sola a la persona; derivación urgente a servicios de urgencias o 112.

Plan de seguridad

Elemento	Acordado con el paciente
Señales de alerta personales	
Estrategias propias de afrontamiento	
Personas y lugares para distraerse	
Personas a las que pedir ayuda (y teléfono)	
Profesionales y servicios	024 (atención a la conducta suicida, 24 h) · 112 (emergencias)
Restricción de medios	

Para el paciente existe una versión propia del plan (PAC-13 · Mi plan de seguridad). Documente siempre la evaluación, la decisión tomada y su justificación.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.